

Rinitis Alérgica

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Archivos Argentinos de Pediatría 2009

Epidemiología

Aproximadamente el 21% de los niños y el 33% de los adolescentes de nuestro país manifiestan síntomas de rinitis y su prevalencia parece incrementarse.

La rinitis alérgica puede incidir sobre la calidad de vida y afectar el rendimiento escolar, la productividad laboral y la actividad social, por alteración de los patrones del sueño, cansancio y disminución de la capacidad de concentración mental.

Definición

Trastorno sintomático de la nariz con inflamación de la mucosa nasal mediada por IgE e inducida por la exposición a alérgenos.

Los síntomas de la rinitis alérgica incluyen:

- Estornudo
- Prurito
- Secreción serosa
- Bloqueo nasal

Clasificación (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma)

1-A. Intermitente: menos de cuatro días a la semana y menos de cuatro semanas al año.

1-B. Persistente: más de cuatro días a la semana y más de cuatro semanas al año.

2-A. Leve: sueño normal, sin impedimento de la actividad diaria como deporte, tiempo libre, escolaridad, trabajo y sin asociación mórbida

2-B. Moderada/grave: se encuentran afectados cualquiera de los aspectos mencionados en la Tabla.

Esta clasificación debe considerarse en pacientes sin tratamiento.

Rinitis alérgica: clasificación

Síntomas (duración y gravedad) - Calidad de vida

<i>Intermitente</i>	<i>Persistente</i>
• < 4 días a la semana • y < 4 semanas	• > 4 días a la semana • y > 4 semanas
<i>Leve</i> • Sueño normal • Sin impedimento de las actividades diarias, deporte, tiempo libre • Escolaridad y trabajo normales • Sin síntomas problemáticos	<i>Moderada/Grave uno o más puntos</i> • Sueño anormal • Impedimento de las actividades diarias, deporte, tiempo libre • Escolaridad y trabajo alterados • Síntomas problemáticos

Aeroalérgenos más frecuentemente responsables de ocasionar rinitis intermitente

- Pólenes de árboles
- Gramíneas
- Malezas
- Esporas de hongos del exterior

Los principales antígenos involucrados en la rinitis persistente son los ácaros del polvo de habitación.

La causa más frecuente de rinitis en niños es la infecciosa, aguda o crónica. La rinitis infecciosa es producida por una larga lista de virus o bacterias, y ser una complicación frecuente luego de un proceso viral. Los síntomas de la rinitis alérgica frecuentemente se confunden con los de la rinitis infecciosa. Los procesos alérgicos de la vía aérea superior, las alteraciones mucociliares y las inmunodeficiencias son factores que predisponen a las infecciones crónicas.

Diagnóstico diferencial de las rinitis

Alérgica • Intermitente • Persistente	Pólipos
Infecciosa • Viral • Bacteriana • Micótica	Alteraciones estructurales • Desviación septal • Hipertrofia adenoidea • Cuerpo extraño • Atresia de coanas
Inducida por medicamentos • Aspirina • Otros	Tumores • Benignos • Malignos
Hormonal	Granulomas • Granulomatosis de Wegener • Sarcoidosis • Infeccioso • Granuloma letal de la línea media
Otras causas: • NARES • Irritantes • Alimentos • Emocional • Atrófica • Reflujo gastroesofágico	Defectos ciliares
	Rinorrea cerebroespinal

NARES: rinitis eosinofílica no alérgica.

Fisiopatogenia

El mecanismo inmunológico de la rinitis alérgica es muy similar al descrito en el asma atópica.

La liberación de mediadores químicos (histamina y leucotrienos, entre otros) originados en la activación del mastocito, sensibilizado con IgE específica de alérgeno, es la responsable de los síntomas.

Etapas

a) la sensibilización: predisposición genética

b) la presencia de síntomas: interacción huésped-medio ambiente.

En la primera etapa, debe existir un huésped predispuesto a inducir una respuesta inmunitaria.

En la *segunda etapa*, el contacto de esta célula sensibilizada con el alérgeno produce la activación celular que desencadena el proceso inflamatorio en dos fases: *inmediata* (dependiente de mediadores químicos e interleucinas) a los pocos minutos del contacto y *tardía*, dependiente del infiltrado celular (eosinófilos, neutrófilos, mastocitos).

Diagnóstico

Sospecha:

- Antecedentes de historia familiar de atopía.
- Cronicidad o recurrencia de los síntomas.
- Presencia de antecedentes personales de alergia (dermatitis, eccemas, asma, hipersensibilidad a alimentos, otitis crónica, sinusitis o tos crónica).

Interrogar sobre:

Características ambientales del lugar donde vive el niño.

El conocimiento de los factores desencadenantes de los síntomas

Examen físico

Afecta: nariz, boca, ojos y oídos.

Facies alérgica:

- Cianosis infraorbitaria (ojeras)
- Pliegue palpebral supernumerario (signo de Denie Morgan)
- Pliegue transversal en la nariz (producido por el prurito y la limpieza constante).
- Esta facies puede estar asociada a signos de respiración bucal, como consecuencia de la obstrucción nasal.
- También son frecuentes el edema y la hiperemia conjuntival.

En el diagnóstico, es indispensable el examen de la cavidad nasal por rinoscopia anterior; se debe realizar con especial atención a la estructura ósea del septum nasal, en busca de desviaciones o deformidades que impidan el normal flujo de aire.

La mucosa puede presentarse inflamada, pálida, gris-azulada, con secreción cristalina.

Los cornetes edematizados pueden obstruir, de manera total o parcial, las fosas nasales.

La faringe puede estar congestiva por el drenaje permanente de secreción que cae del cavum, con hipertrofia del anillo de Waldeyer o sin ella.

Otros signos asociados que favorecen el diagnóstico etiológico de atopía, son:

Eczema

Asma

Sinusitis

Otitis y efusión del oído medio por disfunción de la trompa de Eustaquio.

Manifestaciones clínicas de la rinitis alérgica

Obstrucción nasal	Respiración bucal crónica Falta de aire Hiposmia-Anosmia Voz nasal Babeo Dolor de garganta Ronquido Disfunción tubaria: taponamiento ótico, exudado, disminución audición, infección
Rinorrea	Ruidos nasales Necesidad de "sonarse" la nariz Necesidad de aclararse la garganta Tos faríngea Náuseas, molestia abdominal y disminución de apetito Dilatación abdominal por aerofagia
Prurito palatino y nasofaríngeo	Frotamiento Movimientos linguales enérgicos Cloqueo Gárgaras
Estornudos	Lagrimo por activación de reflejo nasolacrimal Cierre de párpados
Otros síntomas asociados	Epistaxis, fatiga, irritabilidad, prurito ocular, hiperemia conjuntival, edema palpebral, quemosis.

Estudios complementarios:

Se analizarán las principales pruebas que permiten establecer un diagnóstico etiopatogénico adecuado:

- Recuento de eosinófilos en sangre periférica: >750 eosinófilos/mm³, es un inespecífico, la rinitis alérgica puede cursar sin eosinofilia.
- Citología nasal: útil para evaluar la respuesta al tratamiento y la evolución de la enfermedad; se realiza por "sonado nasal" o por hisopado de la mucosa a través de las narinas. El predominio de eosinófilos sugiere patología alérgica, pero no es un hallazgo patognomónico, su ausencia tampoco descarta una causa alérgica.
- IgE total: Es muy solicitada en la práctica pediátrica, pero se considera que la IgE sérica total es un índice muy pobre para predecir rinitis alérgica, por lo tanto, "sola" no es útil para el diagnóstico.
- IgE específica: Es la que permite el diagnóstico definitivo y etiológico de la rinitis alérgica.
- Pruebas cutáneas:
 - *In vivo*: Pruebas cutáneas.
 - *In vitro*: radioinmunoanálisis.
- Estudios complementarios especiales.
 - Rinofibroscopia
El mejor modo de examinar el interior de las fosas nasales es con la ayuda de un espéculo nasal y luz frontal o con otoscopio.
 - Rx de senos paranasales:
 - Mentonasos Se pueden establecer tres niveles de patología:
 - edema de mucosa mayor a 5 mm
 - velamiento total de los senos maxilares
 - nivel líquido.

La neumatización de los senos paranasales existe desde el nacimiento, pero adquiere significado diagnóstico a partir de los dos años.

- Rx de cavum: permite establecer el grado de compromiso de la amígdala faríngea (grados I a IV), la presencia de hipertrofia de la cola del cornete y la hipertrofia de la amígdala palatina.
- Tomografía computada: El costo y la no disponibilidad en todos los centros la ubican como un estudio a realizar en niños con rinitis alérgica complicada y con mala respuesta terapéutica.

COMORBILIDAD

Asociaciones

- *Sinusitis*

Algunos estudios sugieren que la sinusitis es la complicación más común de la rinitis alérgica, que 25-40% de los pacientes con rinitis padecen sinusitis y que el 80% de las sinusitis crónicas bilaterales se asocian con enfermedad alérgica.

- *Otitis media serosa*

La prevalencia de la otitis media con efusión en niños con rinitis alérgica es del 21%, cursa con escasa sintomatología y puede llevar a una progresiva hipoacusia con disminución del rendimiento general del paciente.

- *Conjuntivitis*

Se estima que 33-56% de los casos de conjuntivitis alérgica se dan en relación con la rinitis alérgica. Es más frecuente en la rinitis estacional.

- *Poliposis nasal*

Se estima en un 3-5%. En niños con poliposis nasal es indispensable la investigación de fibrosis quística y disquinesia ciliar.

- *Asma*

Tratamiento

No farmacológico

Educación

Reconocimiento, por parte del niño y de su familia, de la rinitis como enfermedad crónica, esto permite comprender el impacto de la enfermedad sobre la fisiología de la vía aérea y en la calidad de vida.

Control ambiental

Identificación de los desencadenantes que inducen a la inflamación de la vía aérea y evitarlos, con esto se logra reducir los síntomas y un menor requerimiento de fármacos.

- **Humo del tabaco:** es el principal contaminante del interior de las viviendas. Libera gran cantidad de sustancias químicas que ejercen un efecto perjudicial en la vía respiratoria
- **Ácaros:** Las medidas de control están orientadas principalmente al dormitorio del paciente:
 - Debe estar constituido por muebles sencillos y fáciles de limpiar
 - Se deben retirar las alfombras
 - La limpieza se debe realizar con trapos húmedos, sin usar plumero, escobillón, escoba, etc.
 - Evitar los muñecos de peluche, por ser un gran reservorio de ácaros o, en su defecto, hay que lavarlos con agua caliente o congelarlos (freezer) durante 20 minutos.
 - De ser posible, cubrir con fundas antialérgicas colchones y almohadas.
 - Eliminar almohadas, acolchados y colchones de lana o pluma, usar los de fibra sintética.
 - Lavar sábanas y frazadas con agua caliente a más de 60 °C durante 10 minutos.
 - Limpiar regularmente los filtros de los acondicionadores de aire.

- Las aspiradoras con equipos para filtros HEPA son efectivas para disminuir el número de ácaros.
- Realizar la limpieza cuando los pacientes sensibles a los antígenos de los ácaros no se encuentren en el hogar.

- Hongos

Proliferan en ambientes húmedos y cálidos.

- Mantener la vivienda con temperatura inferior a los 18 °C y humedad por debajo del 50%.
- Evitar las peceras y plantas en los dormitorios
- No son aconsejables los vaporizadores
- Mantener una buena ventilación que permita la renovación de aire fresco, con escasos muebles.
- Limpiar con hipoclorito de sodio, paredes y techos manchados de humedad.

- Alérgenos animales

Se encuentran en saliva, conducto anal y orina.

Por lo diminuto de sus partículas se dispersan y trasladan por el aire.

Pueden ser transportados en la ropa a escuelas o lugares donde no hay animales.

Es importante recordar que la supresión de un antígeno no significa la supresión de los síntomas en forma inmediata; hay alérgenos que perduran mucho tiempo en el lugar, como sucede en el caso del gato, cuyos antígenos persisten durante varios meses.

Se debe evitar, en la medida de lo posible y si el niño es sensible, tener animales domésticos en la casa. Siempre deben tener prohibida la entrada al dormitorio.

El baño rutinario de los animales domésticos permite reducir su capacidad antigénica.

- Pólenes

Proviene de las gramíneas, malezas y árboles.

Se trasladan fácilmente por el viento; esta característica

Su evitación es imposible; la concentración en el dormitorio disminuye al mantener las ventanas cerradas durante la noche y airear a primera hora de la mañana.

Tratamiento farmacológico

Puntos clave a tener en cuenta para la selección de medicamentos son:

- La medicación no tiene un efecto duradero en caso de interrumpir su uso. Por lo tanto, ante síntomas persistentes se requiere terapia de mantenimiento.
 - No se ha verificado que el tratamiento prolongado produzca taquifilaxia.
 - Los medicamentos utilizados para el tratamiento de la rinitis son muy comúnmente administrados por vía intranasal y oral.
 - Algunos estudios han comparado la eficacia relativa de estos medicamentos, de los cuales los corticoides intranasales son los más efectivos.
- No obstante, la elección del tratamiento también depende de otros criterios.
- No se recomienda la inyección intramuscular de corticoides debido a la potencial capacidad de producir efectos colaterales sistémicos.
 - No se recomienda inyección intranasal de corticoides debido a la potencial capacidad de producir efectos colaterales graves.

Cuadros intermitentes con grado de gravedad leve:

Antihistamínicos orales tópicos, solos o asociados a descongestivos.

Cuadros intermitentes de intensidad moderada- grave y en las persistentes leves:

Corticoides inhalatorios, antihistamínicos orales y tópicos, o descongestivos y cromonas. Debemos consignar que si la sintomatología es exclusivamente nasal, los fármacos de primera elección son los corticoides tópicos y si presentan conjuntamente sintomatología ocular, la primera elección debe recaer en los antihistamínicos por vía oral.

Cuadros persistentes de intensidad moderada- grave

Corticoides tópicos combinados con las otras alternativas terapéuticas ya descriptas, antihistamínicos H1, descongestivos, anticolinérgicos, en los casos de rinorreas graves e incrementar la dosis de esteroides, y ante la carencia de respuesta se impone la reevaluación diagnóstica integral.

Antihistamínicos

1. Primera generación o sedantes:

- Difenhidramina
- clorfeniramina,
- ciproheptadina

2. Segunda generación o no sedantes

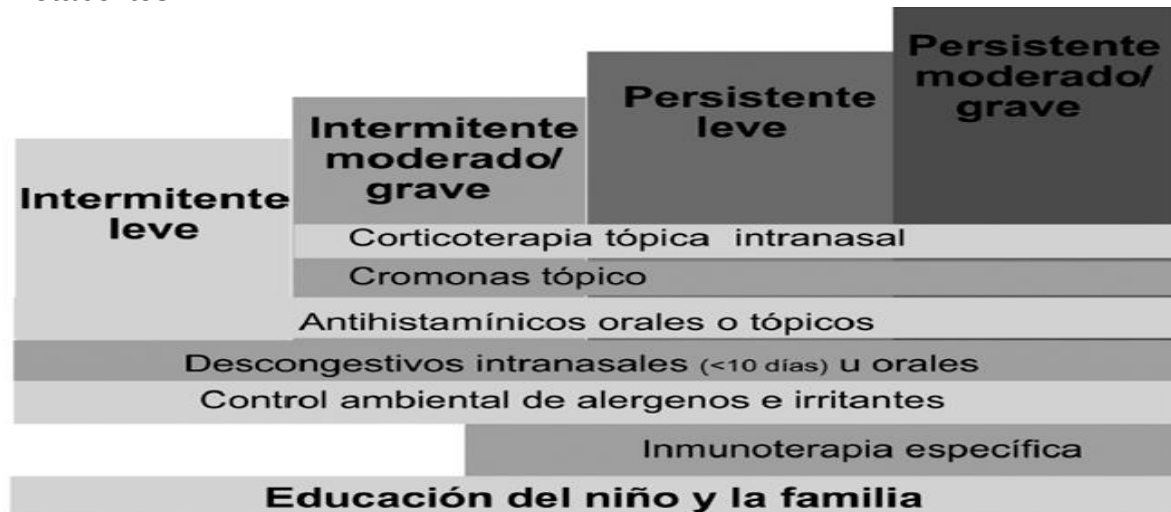
- loratadina
- cetirizina
- epinastina
- levocabastina
- azelastina

3. Metabolitos de estos fármacos

- fexofenadina
- desloratadina
- levocetirizina.

Debemos ser cuidadosos al administrar antihistamínicos de primera generación con efecto sedante, porque producirán depresión en el sistema nervioso central con somnolencia y, también, disminución en el rendimiento laboral e intelectual.

El tratamiento óptimo consiste en administrar antihistamínicos de segunda generación o sus metabolitos.



Manejo general de la rinitis

	estornudos	rinorrea	obstrucción nasal	prurito nasal	síntomas oculares
Antihistamínicos					
oral	++	++	+	+++	++
intranasal	++	++	+	++	0
intraocular	0	0	0	0	+++
Corticosteroides					
intranasal	+++	+++	+++	++	++
Cromonas					
intranasal	+	+	+	+	0
intraocular	0	0	0	0	++
Descongestivos					
intranasal	0	0	++++	0	0
oral	0	0	+	0	0
Anticolinérgicos	0	++	0	0	0
Antileucotrienos	0	+	++	0	++